# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 74261
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-17 14:55:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : JOSE LEOPOLDO MUNOZ MERCADO | | | RUN | : 3.077.251-2 |
| F.Nac | : 10-01-1933 | Edad | : 90 AÑOS, 10 MESES | Género | : Masculino |
| Dirección | : KM.2 CAM. A SAN FABIAN, SECTOR LLAHUIMAVIDA ** | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : FONASA B | Teléfono | : 940942511 | | |
| Fecha Ingreso | : 2023-11-13 | Fecha Egreso | : 2023-11-17 14:55:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N19.X-INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA.

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONÍA ATS III
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA:
-KDIGO III
-OBS POSTRENAL
CA PRÓSTATA AVANZADO EN HT CON MT EN CUIDADOS PALIATIVOS
POSTRADO (DEPENDENCIA TOTAL)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE CA PROSTATICO EN CUIDADOS PALITIVOS, CONSULTA EN URGENCIAS 12/11/23, TRAIDO POR FAMILIARES, ESTUVO HOSPITALIZADO 7 DIAS ATRAS POR NEUMONIA, PRESENTA COMPROMISO GENERAL Y REQUERIMIENTO DE OXÍGENO, POR LO QUE RECONSULTA, SEGÚN FAMILIAR, SECUNDARIO A RETENCIÓN URINARIA AGUDA, DOLOR PÉLVICO, CONSTIPACIÓN, INAPETENCIA.
ACORDE A RELATO, MENCIONA QUE EN DOMICILIO REINICIA CON ESTERTORES BILATERALES AUDIBLES ADEMÁS DE DESATURACIÓN (84%), EXACERBACIÓN DE DISNEA BASAL, Y ESCASOS ACCESOS DE TOS, POR LO QUE DECIDE REACUDIR.
DURANTE ESTANCIA HOSPITALARIA, DESTACA AUMENTO DE CREATININA BASAL (7+) POR LO QUE DECIDEN COLOCAR SONDA FOLEY. SEGUN REGISTRO, IMPRESIONA EGRESO DE APROX 4000CC+ DESDE INGRESO.
EN VISTA DE CONDICIONES, SE DECIDE INGRESO

PCTE EN MEJORES CONDICIONES GENERALES, HOY COMPLETA 5 DIAS TTO ATB CEFTRIAXONA.
36 HRS SIN REQUERIMEINETO DE OXIGENO, ALIMENTANDOSE OK
HDN ESTABLE, SAT 93% FIO2 AMB

PIEL Y CONJUNTIVAS PALIDA, LESION NASAL POR ANTERIOR USO DE SONDA NASOGASTRICA, EN REGRESION
TORAX MP PRESENTE CON CREPITACIONES BILATERALES EN REGRESION
ABDOMEN PLANO BLANDO NO DOLOROSO,
EEII SIN EDEMA, SIN SIGNOS TVP
NEUROLOGICO GLASGOW 15 PTOS, SIN FOCALIZACION NEUROLOGICA

POR MEJORES CONDICIONES, RECUPERACION DE FUNCION RENAL (CREA 1.5), ESTAR SIN REQUEREIMIENTO DE OXIGENO ADICIONAL Y DESCENSO DE PARAMETROS INFLAMATORIOS, SE DECIDE TRASLADO A HOSPITALIZACION DOMICILIARIA, PARA COMPLETAR TTO ATB Y MANEJO POR KINE, SE MANTIENE SONDA FOLEY, PARA EVITAR NUEVA FALLA RENAL POST RENAL.

## PLAN DE MANEJO:

EDUCACION A FAMILIARES SOBRE SONDA VESICAL
TRATAMIENTO DE BASE POR CA PROSTATA, SEGÚN POLI ONCOLOGIA CHILLAN
CONTROL Y SEGUIMIENTO POST ALTA HODOM: POLI AD Y CP
EVALUAR REQUERIMIENTO DE SONDA VESICAL PERMANENTE

## INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADO
2. REGIMEN LIVIANO ASISTIDO MAS AGUA
3. KINE MOTORA Y RESPIRATORIA
4. CEFTRIAXONA 2 GR AL DIA EV POR 3 DIAS (HASTA EL LUNES INCLUSIVE)
5. PARACETAMOL 500MG 2 C/8HRS SOS SI DOLOR O FIEBRE
6. CARVEDILOL 6,25MG 1 AL DIA VO
7. FUROSEMIDA 40MG ½ AL DIA VO
8. LACTULOSA 10 ML C/8HRS VO
9. QUETIAPINA 25MG 1 POR NOCHE VO, SOS SI AGITACION
10. EN LO POSIBLE CONTROL O SEGUIMIENTO EX FUNCION RENAL

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO